DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: JOSE MANUEL CASTAÑO GARCIA **Identificación** CC 16348303
Edad: 70 AÑOS **Empresa:** EMSSANAR S.A.S SUBSIDIADO-2025-2
Sala: SALA DE ENDOSCOPIA **Fecha programación de cirugía:** 03/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA	AMI	

Cirujano: JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad:** GASTROENTEROLOGIA
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES257 JOHANN MARIO ALVAREZ GIL **Especialidad** GASTROENTEROLOGIA
441302 **ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA**
Dx Preoperatorio: C158 LESION DE SITIOS CONTIGUOS DEL ESOFAGO

Dx Postoperatorio: K294 GASTRITIS CRONICA ATROFICA

Tipo de Herida: LIMPIA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 03/11/26 **Fecha Final** 03/11/26
Hora Inicio 13:10:00 **Hora Final** 13:21:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
PROCEDIMIENTO CON SEDACIÓN BAJO ANESTESIOLOGIA GENERAL DRA ELBIA RODRIGUEZ(FENTANILO, LIDOCAINA, PROPOFOL)***
SE UTILIZARON TODAS LAS MÉDICAS DE BIOPROTECCIÓN PARA PREVENIR LA INFECCIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y PACIENTE. (BATA ANTIFLUIDOS, N95, CARETA Y DOBLE GUANTE).
PROCEDIMIENTO REALIZADO CON EQUIPO OLYMPUS CV-180 EVIS EXERA II
REALIZADO POR JOHANN ALVAREZ.
****ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA****
***INDICACIÓN: Sindrome pilórico ?
ESOFAGO: Normal hasta tercio proximal. En tercio medio y distal se observo lesion elevada, de bordes irregulares, ulcerada, extensa, de aprox 10 cms de longitud, que compromete el 80% de la circunferencia, friable de la cual se toman biopias (6 fg). Se evidencia extension hasta UEG. Carddias franqueable.
ESTOMAGO: Explorado hasta píloro incluyendo retrovisión para pequeña curva y fondo gástrico normales. lago gastrico mucoso biliar. Mucosa corporoantral adelgazada sin sangrado sin ulceras. Motilidad antral normal. Píloro franqueable.
DUODENO: Normal hasta segunda porción.
BIOPSIAS: FRASCO 1: Lesion de esofago
***CONCLUSION:
1. LESION IREGULAR EXTENSA DE ESOFAGO A ESTUDIO: NEO?
2. GASTRITIS CORPOROANTRAL ATROFICA LEVE

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐
FRASCO 1: LESION DE ESOFAGO



JOHANN MARIO ALVAREZ GIL
Reg. 1130587580
GASTROENTEROLOGIA

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***